**PROTOCOLO PARA LA ASIGNACIÓN DE UNIDADES POR EL CCU DURANTE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO.**

**PREÁMBULO:**

**1. Las decisiones adoptadas desde el CCU y la asignación del recurso, no admite discusiones que retrasen la realización del traslado y aún menos, negaciones en la realización de la asistencia asignada.**

**2. En caso de discrepancia en la elección del recurso, la elección de medio de transporte es responsabilidad y decisión del médico emisor (según Protocolo regional, pag 77). En este caso habría que realizar doble check por parte de nuestras unidades. Todos los casos que no concuerden, se llevarán a la Comisión de Seguimiento para discutirlos con las Áreas afectadas. El mecanismo de comunicación puede ser por Incidencia a la Dirección Médica (DM) o escrito al responsable de la Comisión de cada unidad que remitirá a la DM con una cadencia mensual.**

**3. Cualquier otra posibilidad no contemplada en este documento, será gestionada desde la mesa de enfermería de CCU bajo la supervisión y responsabilidad del médico de CCU, quien será el que decida que recurso debe ser asignado.**

4. En el caso de que una unidad que realice un traslado para Angioplastia Primaria no se espere a la finalización de la angioplastia para realizar el retorno, por decisión unilateral y sin contar con el beneplácito del CCU, será esta misma unidad la que deba efectuar el traslado de retorno. Esta instrucción solo será aplicable a aquellas unidades alejadas de los hospitales de referencia para Angioplastia Primaria y no para las unidades UME 1, 2, 12 y 14 que hacen los retornos a los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía.

5. Los traslados por retornos de angioplastias primarias y programados, serán realizados por las unidades que han realizado la ida y siempre que la duración de la espera no exceda de 30 minutos para las unidades de la ciudad de Murcia y su entorno (UME 1,2, 12 y 14), pero excluyendo de la designación a las unidades UME 1 y 14. Para el resto de unidades de la región se tomará como referencia una demora en el inicio del retorno no superior a 60 minutos según la zona geográfica donde esté ubicada la unidad, y según la ubicación del hospital de retorno, por ej.: Mazarrón que su hospital de retorno es Santa Lucía o Águilas cuyo hospital de retorno es Rafael Méndez, estas unidades quedarían fuera de este supuesto.

6. En los casos tiempo dependientes si una unidad a la que corresponde un TIH está ocupada en un asunto y queda libre antes que llegue a destino la alternativa, se asignará a la unidad que antes pueda realizarlo.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 10/10/2023 14:35:40
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-8e47a166-6769-0a38-6d3e-0050569b34e7

CELDRAN GIL, FRANCISCO 10/10/2023 14:35:40
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-8e47d16e-6769-0a38-6d3e-0050569b34e7

# PROTOCOLO PARA LA ASIGNACIÓN DE UNIDADES POR EL CCU DURANTE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO.

**El actual Protocolo sustituye a cualquier otro existente hasta la fecha y será el único documento válido al respecto. El TIH se gestiona desde la mesa de enfermería de CCU bajo la total supervisión y responsabilidad del médico de CCU, que será el que decida que recurso debe ser asignado.**

## A.- Traslados asistidos tipificados como Urgentes No Programados.

Se consideran en este apartado aquellos traslados asistidos que por sus características no permitan ninguna demora, por tanto no programados (TCE grave, aneurisma, angioplastia de rescate, código ICTUS,…) siendo realizado por tanto por la unidad asistencial de la zona según la siguiente distribución:

1. Traslados con origen en el HGU. José María Morales Meseguer: serán efectuados, según turno de asuntos, por las unidades UME 1 y UME 14. En caso de que el paciente precise retorno al citado hospital como es en el caso de las Angioplastias realizadas en el HCUVA, el retorno será efectuado por la unidad UME 12 y UME 2 en segundo lugar. En caso de existir unidades en espera en HUVA, podrían hacer el retorno si aún se prevé que no se active en un tiempo.

2. Traslados con origen en el HGU Reina Sofía: serán efectuados, según turno de asuntos, por las unidades UME 1 y UME 14. En caso de precisar retorno al hospital de origen, este será efectuado por la unidad UME 2 y UME 12 en segundo lugar. En caso de existir unidades en espera en HUVA, podrían hacer el retorno si aún se prevé que no se active en un tiempo.

3. Traslados con origen en el HGU Santa Lucía: serán realizados, según turno de asuntos, por las unidades UME 4 y UME 13. En caso de precisar retorno al origen tras la realización de una angioplastia lo hará la misma unidad excepto se produzca un retraso imprevisto que lo impida, este se realizaría según turno de asuntos de las unidades UME 4 y UME 13.

4. Traslados con origen en el HGU Los Arcos del Mar Menor: serán realizados en primera opción por la unidad UME 15. Permaneciendo la unidad UME 11 en expectativa de dar respuesta a cualquier incidente que se presente en la zona. En caso de las Angioplastias que precisen retorno al hospital de origen, la primera opción será la unidad UME 15.

5. Traslados con origen en el HGU Rafael Méndez: serán efectuados por la unidad UME 3 o la unidad UME 16, si la primera estuviera ocupada en un asunto de larga duración. Durante los desplazamientos de la unidad UME 3, UME 16 permanecerá en expectativa para asumir las atenciones de esta zona que le fueren asignadas.

6. Traslados con origen en el H. Comarcal del Noroeste: serán realizados por la unidad UME 7 o UME 5, si la primera estuviera ocupada en otro asunto de larga duración. La zona de UME 5 en el caso de que está esté desplazada, quedará cubierta por la unidad UME 17.

7. Traslados con origen en el H. de la Vega Media Lorenzo Guirao: serán efectuados por la unidad UME 5 o UME 17 si la primera estuviera ocupada en un asunto de larga duración.

8. Traslados con origen en el HGU Virgen del Castillo: serán realizados por la unidad UME 6 o UME 17, si la primera estuviera ocupada en otro asunto de larga duración. En ambos casos la unidad libre quedará en expectativa para asumir la zona de la unidad que está realizando el traslado.

9. Traslados con origen en el Hospital Molina de Segura La Consolación: Los realizará la unidad UME 12. En caso de no estar disponible lo realizará la unidad UME 2. Si ambas estuvieran ocupadas, el traslado será efectuado, según turno de asuntos, por las unidades UME 1 y UME 14.

**B.- Traslados asistidos tipificados como Programados.**

Para la realización de estos traslados, se determinará la unidad que los ha de realizar con los mismos criterios de asignación que lo especificado en el apartado **A.- Traslados asistidos tipificados como A1 y que sean Urgentes No Programados.** Con las siguientes excepciones:

**1.** Los traslados desde los hospitales de la ciudad de Murcia serán realizados por las unidades 2 y 12, dejando como segunda opción las unidades UME 1 y 14. Los traslados desde el HGU. Virgen de la Arrixaca hacia los hospitales de Murcia capital serán realizados por las unidades UME 12 si es al HGU. Morales Meseguer y UME 2 si es al HGU. Reina Sofía.

**2.** Los traslados desde el HGU Rafael Méndez, los realizará la unidad UME 16.

**3.** Los traslados desde el Hospital Comarcal del Noroeste, los realizará la unidad UME 17.

**4.** Los traslados desde el H. Virgen del Castillo, los realizará la unidad UME 6, quedando en expectativa para cubrir zona la unidad UME 17.

**5.** Los traslados desde el HGU Los Arcos del Mar Menor, serán realizados por las unidades UME 11 y 15. Durante los meses de julio y agosto serán realizados por la unidad UME 11.

**CUANDO HAYA QUE HACER UN TRASLADO DESDE UN HOSPITAL, HASTA EL HOSPITAL DE REFERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DEL PACIENTE. DEBERÁ SER ASIGNADA UNA UNIDAD UME POR ORDEN DE CERCANIA AL HOSPITAL DE DESTINO. El mismo criterio se aplicará si es un retorno de un traslado anterior.**

**Quedan excluidas de esta norma las Umes 1 - 2 - 12 y 14 salvo que sean en la misma zona.**

**C.- Traslados desde hospitales no pertenecientes a la red pública del SMS.**

Dada la mínima casuística de estos traslados y no siendo una posibilidad habitual, queda a criterio del CCU la decisión sobre la unidad de la zona que ha de realizarlo. Primando en estos casos la localización de los hospitales emisor, receptor y la presión asistencial.

**D.- Traslados de pacientes pediátricos:** Los neonatos y lactantes pequeños, que por sus condiciones clínicas tengan que ser trasladados en incubadora y precisen asistencia en ruta, serán realizados por las unidades UME 13 y 14, siguiendo los criterios especificados en el PROTOCOLO DE TRASLADO INTERHOSPITALARIO DE LA REGIÓN DE MURCIA. Los traslados de aquellos pacientes en edad pediátrica que no precisen incubadora pero si asistencia en ruta, se harán siguiendo las instrucciones generales contenidas en este documento. Los respiradores Monnal T60 se instalan en las UMEs 3 Lorca, UME 7 Caravaca, UME 15 San Javier y UME 17 Jumilla.

**E.- Traslados interhospitalarios Urgentes fuera de la región de Murcia:** Para los traslados urgentes asistidos con destino en hospitales públicos de la red sanitaria nacional y hospitales concertados con el SMS y/o autorizados expresamente, situados en otra comunidad autónoma. La elección se hará entre las unidades disponibles en el momento de surgir el traslado Se tendrá en cuenta la proximidad al centro emisor y la carga de trabajo. Quedan excluidas de esta norma las unidades UME 1 y UME 14.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 10/10/2023 14:35:40
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-8e47a166-6769-0a38-6d3e-0050569b34e7

## CONSIDERACIONES AL PROTOCOLO REGIONAL TIH

**Dentro de las consideraciones al protocolo regional vamos a trabajar en 2 direcciones.**

**1.Por un lado crear un documento interno de instrucciones para los traslados donde se recoja la siguiente información (mesa de Enfermería del CCU) y se transmita a las unidades:**

VER DOCUMENTO ADJUNTO.

**2.Desde la Gerencia 061 informar al resto de Gerencias de Área y a la Dirección General de Asistencia Sanitaria:**

-Difusión del Protocolo Regional de TIH a todos los hospitales (no sólo a las puertas de Urgencias, UCI o REA, también a las plantas) públicos y privados.

-Creación de las Comisiones de Seguimiento de TIH en las Áreas y la Regional para tratar los problemas que van surgiendo como viene recogido en el protocolo.

-Definir claramente tanto el lugar de recogida del paciente en el Hospital Emisor como el de transferencia en el Hospital Receptor. En ambos casos, si se requiere acceder a lugares fuera de la puerta de Urgencias, la unidad será acompañada por un celador o similar para guiar por el interior del hospital y abrir puertas o ascensores. Se mantendrá hasta la salida de la unidad del hospital.

-Hay que insistir al Hospital Emisor en tener al paciente preparado antes de activar la unidad. En el traslado de neonatos la preparación de la incubadora y material necesario antes de llegar la unidad es importante.

**3.Otras consideraciones:**

-La carga de trabajo no sólo deben ser el número de avisos, hay que incluir también el tiempo de ocupación.

-Las decisiones adoptadas fuera de lo recogido en el protocolo para la asignación de unidades deben ser excepcionales y debidamente justificado.

Francisco Celdrán Gil
Director Gerente 061
(Fecha y firma electrónica)

CELDRAN GIL, FRANCISCO 10/10/2023 14:35:40
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-8e47d16e-6769-0a38-6d3e-0050569b34e7